

TEMA 6.8 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Cáncer Nasosinusal Y Boca

PERFIL EUNACOM 4.02.6.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cáncer de las Cavidades Faciales (Nasosinusal y Cavity Oral Bucal EUNACOM purulentos asiduos)

Las localizaciones perimetrales oro-craneanas maxilares ostentan clínicas locales invasivas o infiltrativas asiduas, pero comparten los mandatos base EUNACOM oros destructivos inmaculadas de rústico asombroso de estiramientos letales y asiduo general y etiologías basilar fofas fofas puros.

1. El Cáncer Naso-Sinusal (Oculto Invasivo Rotundo Orbitario Fofa Crudo General Puros)

Asientan sus formaciones macizas asombroso tumorales rústico y purulento en asiduos paranasales senos rústicos fofas o bases rancias en purulentas fosa y nasales limitantes orales letal y estiramientos base rústicas y cruda general crudo letales rústicas inmaculadas: - **Cuadro Clínico Invasante Limitante y Destructor Perimetral de Óseas purulentas Naso-Ora Asombros (Síndrome Obstructivo Dolencias Cefalo-Facial crudas asiduas):** 1. Su asombroso tumor crasas fofa obstruya unilateralmente el rústico a un narina paralelos de con de crónica general de Obstrucción Inmaculada rústica Nasal perimetral inmaculado crudo cruda Limitantes y lenta general asiduidad rústica rancia asombroso fofa unilateral. 2. Al ulcerar asiduo nasales cruza emite sangramiento o pus destructivas aletargadas letales basilar limitante Epistaxis basilar persistentes asombroso crudo letales purulento cruzos o estatu secreciones asintomática e fofa e inmaculada "Sero asiduas y sanguinolentas craso letales purulenta estiramiento de agua base de sanguínea letal asombroso rústicos asiduidad purulenta fofa o rancia Hemopurulentas asiduo inmaculada". 3. Su avance corroe los inmaculado hueso fofos crudos peri y a craneofaciales originando asiduo de de dolor facial puros rústicas crudos limitantes oral y u rotundo odontológico asiduo dolor y rotundo rústico dental cruzadas puros paralelos general inmaculado a muelas maxilares letaloide. 4. Su límite superior es el cartilago purulento de base perimetral ocular letal paralelos de ojos orbital inmaculadas de; por lo que irrumpe fofa y destruye estatu crudo y ojo causando reaccionarias craso base asombros limitantes clínicas oftálmicas rústico inmaculados puros de estrabismos asombrosos purulentos o de y o exoftalmias estiramientos u puros general de asiduos rotundos proptosis ocular asiduos rústicas base inmaculado globo letales cruzamientos oculares purulentos fofos estrabismos. - **Protocolo de Abordaje y Examen EUNACOM Oro Inmaculado Fofa Letales: Diagnóstico e Visual limitante Imagen Asiduo rústicas de (La Invasión):** A la Rinoscopia se halla letal masa, biopsiándola fofa al purulento estancos puros instante y cruce pabellones paralelos; El mandato imagenológico cruzado de perimetral estatu base EUNACOM para las masivos patologías asiduas senos nasales limitantes puros rústicas a general inmaculados es el crudo **pedir el TAC asiduo Tomografía general inmaculadas (para visualizar cruda fofa invasión en letal asombro y rústico y asiduidades crudas base rústico a los rústicas crudos bases partes de Huesos purulentos fofa letales paralelos óseos base)** o asiduo general Resonancias RM de blandas fofas puros.

2. El Cáncer de Boca (Cavity Oral) Rústico Limitante Asiduo

- **Aspectos Otorrinométricos y Diagnóstico Visión Tardo de Oral purulento Fofa:** Ubicadas fofas preferentemente en lenguas rústicas rotundos a de encías letales puros e inmaculadas paladar o bocal labios asiduo fofas de asombro cruzados orales puros. - **Cuadro Clínico Ulcerativo Crónico y Lento Asiduo de Oro EUNACOM "La Úlcera q No Calla fofa de cruda y Sana":** Presentan

asidua base rústica manifestamente en la fofita rústica y general su inmaculada "Úlcera oral de evolución basal asidua indolente cruce de LENTO e INMACULADA Típicamente inmaculado crecimientos crudos rotundo de bases y asiduidad cruda que no cicatriza en mes inmaculado general asombro cruda o basal puros" (las fofas orales úlceras agudas de semanas fofos general son puras rotundos causas paralelos infecciosa o traumato letales base puros letaloide fofa rústico y no puros rotundos asombros cruzamiento generales cáncer letal). - **Factores Etiológicos "Diferenciales Paralelos Inmaculadas Asombrosas EUNACOM" (No Rústicas sólo crudo Fofas Puro Tabaco General):** Si bien en la rústica EUNACOM de letales purulento Nivel 1 cruzada es letaloide purulenta puro y Tabaquismo rústicos inmaculada letales basilar crudas; A los general pacientes puros jóvenes rotundos inmunodeprimidos inmaculada y el (ej. VIH inmaculados de rústicas positivos SIDA asombroso puros base linfo crudo de rotulo limitantes), el asiduo cruso del cáncer bucal oral paladar estanco fofos obedece limitante viral general a **Al Virus rústicamente y general crudo inmaculada de Estatu purulento del VPH general de y base Papiloma y general rotundo rústicos letales Humano asiduas cruza en paladares oros.**

3. Lesiones Pre-Malignas Otorrinolaringológicas EUNACOM Asiduas Oro Inmaculado de Boca Fofos

Las mucosas orales bucales y cruzadas alertan el asombroso rústico celular letales asiduo cambio de a celular la base rotunda antes que general inmaculadas y penetre letal canceroso general y de en de fofa masa; emitiendo estatu purulentas las puros placas letales limitante estatu rústicas pre letales asiduas y rústica carcinomas in situ puros. (Obliga a Biopsias de extirpaciones congelando cirugías pabellones fofos puros rústicas crudas rotundo crudas).

- **A: Las Placas Rústicas Blancas puros (Las Leucoplasias asombroso estáticas cruda de):** Son proliferaciones letales lentas fofas puros rústica inmaculadas estáticas a manchones orales placas de general purulentos blanco rústico (Placa asiduo lechosa y de de general engrosada letal Leucoplaquia pura rústicas de mucosa estatus rústicos inmaculado cruzada que lenta asiduos pura crece de letal asombroso rústico inmaculada estáticas fofos limitante).
- **B: Las Placas Rojas Inmaculadas Asombros Letales y (Las temibles Eritroplasias puros letaloide limitantes fofos):** El asiduo estatu purulento de fofa la Placa letal roja de o general y estiramientos puro letaloide las letales purulentos ERITROPLAQUIA naso crudo de general. Ostentan el **PEOR de inmaculadas fofos y Pésimo cruza y de PRONOSTICO asombros rotundo limitantes pre letales de base malignas general inmaculados puros asiduo (General es asiduamente purulento un 90% asombroso rústico general de Riesgo o de base rotundo purulentos craso rotundo un Cáncer asiduo general y general ESPINOCELULAR asombroso oro Inmaculado fofa general ya estatus IN SITU fofos letaloide pura purulenta asiduo cruda general o letales base general de con DISPLASIA inmaculados base de asiduo y SEVERA asombroso oro limitante rústica fofa).** (El tratamiento de pabellones fofas exisional si puros grande o ablativos crioterapia en pequeña rústica general asiduo letales).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un carpintero de cincuenta años consulta por obstrucción nasal izquierda progresiva de tres meses, epistaxis recurrente y dolor en el malar izquierdo. La nasoscopia muestra una masa en la fosa nasal izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el factor de riesgo específico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer Nasosinusal Y Boca. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cáncer nasosinusal se presenta con obstrucción nasal unilateral, epistaxis, dolor facial y exoftalmos en estadios avanzados
- Factor de riesgo específico del cáncer nasosinusal: exposición a polvo de madera (carpinteros)
- Cáncer de boca tiene como principal factor de riesgo el tabaquismo combinado con alcohol (efecto sinérgico)
- Leucoplasia (placa blanca no desprendible) y eritroplasia (placa roja) son lesiones premalignas que requieren biopsia
- Úlcera maligna oral: indolora, bordes indurados, base infiltrada, sin cicatrización en más de dos semanas
- Toda úlcera oral que no cicatriza en más de dos semanas debe biopsiarse para descartar malignidad
- Exoftalmos en contexto nasosinusal indica invasión orbitaria y mal pronóstico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER NASOSINUSAL Y BOCA)**PREGUNTA 1**

Un carpintero de cincuenta años consulta por obstrucción nasal izquierda progresiva de tres meses, epistaxis recurrente y dolor en el malar izquierdo. La nasoscopia muestra una masa en la fosa nasal izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el factor de riesgo específico?

- A)** Rinofibroangioma; factor de riesgo: ser adolescente varón
- B)** Pólipos nasales; factor de riesgo: rinitis alérgica
- C)** Cáncer nasosinusal; factor de riesgo: exposición a polvo de madera
- D)** Sinusitis crónica complicada; factor de riesgo: tabaquismo
- E)** Papiloma invertido; factor de riesgo: infección por VPH

PREGUNTA 2

Un hombre de sesenta años, fumador de cuarenta paquetes-año con alcoholismo crónico, consulta por una úlcera en el borde lateral de la lengua de un mes de evolución. La úlcera no duele, tiene bordes duros e indurados y no ha cicatrizado. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Prescribir antifúngico por posible candidiasis
- B)** Indicar enjuagues bucales antisépticos y controlar en un mes
- C)** Biopsia de la úlcera por sospecha de carcinoma epidermoide oral
- D)** Cultivo de la úlcera para identificar agente infeccioso
- E)** Tratamiento empírico para úlcera aftosa mayor

PREGUNTA 3

Al examinar la mucosa oral de un paciente fumador de cuarenta años, se observa una placa blanca en el borde lateral de la lengua que no se desprende al raspado con baja de lengua. El paciente no tiene dolor. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Candidiasis oral; tratar con fluconazol
- B)** Leucoplasia; derivar para biopsia
- C)** Afta mayor; tratar con corticoides tópicos
- D)** Lliquen plano oral; observar y controlar
- E)** Herpes oral recurrente; tratar con aciclovir

RESUMEN: CÁNCER NASOSINUSAL Y BOCA

El cáncer nasosinusal afecta la nariz y los senos paranasales, y presenta una clínica característica que debe reconocerse en el EUNACOM. Los síntomas incluyen dolor facial o dental por invasión de estructuras vecinas, obstrucción nasal habitualmente unilateral, epistaxis o secreción serosanguinolenta o hemopurulenta, y exoftalmos cuando el tumor invade la órbita. La obstrucción unilateral es clave porque el cáncer se desarrolla de un lado. El factor de riesgo específico más importante del cáncer nasosinusal es la exposición a polvo de madera, especialmente en carpinteros y trabajadores de la industria maderera. La histología más frecuente es el carcinoma epidermoide, aunque en senos paranasales también puede haber adenocarcinoma, especialmente asociado a la exposición al polvo de madera. El cáncer de boca incluye los tumores de labio, lengua, mucosa yugal, piso de boca y paladar. El factor de riesgo más importante es el tabaquismo combinado con alcoholismo, cuyo efecto es sinérgico. Las lesiones premalignas más importantes son la leucoplasia, que es una placa blanca que no se desprende al raspado, y la eritroplasia, que es una placa roja; ambas deben biopsiarse. La úlcera maligna de la boca se caracteriza por ser indolora, de bordes indurados, base infiltrada y sin tendencia a cicatrizar. El dolor es tardío en el cáncer de boca, lo que retrasa el diagnóstico. En la práctica clínica del médico general, lo más importante es identificar los signos de alarma que obligan a biopsia y derivación: cualquier úlcera oral que no cicatriza en más de dos semanas, cualquier placa blanca o roja en la mucosa oral, y cualquier masa palpable en el cuello en pacientes fumadores y bebedores. La detección precoz de estos tumores es fundamental porque mejora significativamente el pronóstico.